

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE SCHUTTE (SSEIT-33)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación del Autoinforme de Inteligencia Emocional Percibida / Rasgo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Inteligencia Emocional de Schutte (SSEIT: 33 reactivos).
Nombre Original	Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test (SSEIT / SREIT / AES; Schutte et al., 1998).
Autores Originales	Dra. Nicola S. Schutte, Dr. John M. Malouff et al. (Universidad de Nueva Inglaterra).
Adaptación Hispana	Chico (1999), Universidad Rovira i Virgili; García-Fernández et al. (2014), España.
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Inteligencia emocional rasgo: percepción, regulación y uso afectivo.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme de 33 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 14 años). Ámbito clínico, educativo y de recursos humanos.
Tiempo de Administración	6 a 10 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, docente y de investigación científica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

El SSEIT fue concebido para operacionalizar y medir de forma breve el modelo seminal de inteligencia emocional propuesto por Salovey y Mayer (1990). La **inteligencia emocional** se define como la capacidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones; la habilidad de acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la destreza para comprender las emociones y el conocimiento emocional; y la capacidad para regular reflexivamente las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual.

Frente a medidas de rendimiento máximo (tests de habilidad objetiva como el MSCEIT), el SSEIT evalúa la **inteligencia emocional percibida o autoeficacia emocional rasgo**, la cual constituye el predictor más directo de la autorregulación cotidiana y la salud mental ambulatoria (Petrides & Furnham, 2001). Los reactivos cubren cuatro dominios esenciales identificados factorialmente (Ciarrochi et al., 2001; Saklofske et al., 2003):

- Percepción y Valoración Emocional:** Identificación precisa de emociones en el propio cuerpo, el lenguaje y las señales faciales ajenas.
- Regulación de Emociones Propias:** Capacidad intrapersonal de reparar el malestar afectivo y fomentar emociones placenteras.
- Regulación de Emociones Ajenas:** Habilidad interpersonal y empatía conductual para calmar, motivar o inspirar a los demás.
- Utilización Emocional:** Uso intencionado de las emociones para guiar la creatividad, el razonamiento y la resolución adaptativa de problemas.

Neurobiológicamente, una alta competencia en el SSEIT se asocia a una robusta activación de la corteza prefrontal ventromedial, una adecuada función del giro fusiforme en el reconocimiento facial afectivo, modulación inhibitoria amigdalina eficaz y mayor volumen de sustancia gris en la ínsula anterior.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Dimensión Factorial	Ítems (33)	Nº Ítems	Definición Operativa y Competencias Evaluadas
1. Percepción Emocional	5*, 9, 15, 18, 19, 22, 25, 29, 32, 33*	10 ítems	Lectura de microexpresiones, tono de voz y reconocimiento de estados internos.
2. Regulación Propia	2, 3, 10, 12, 14, 21, 23, 28*, 31	9 ítems	Autocontrol de impulsos, automotivación y recuperación rápida tras frustración.
3. Regulación Ajena	1, 4, 11, 13, 16, 24, 26, 30	8 ítems	Competencia prosocial, validación afectiva y capacidad de consolar e inspirar.
4. Utilización Emocional	6, 7, 8, 17, 20, 27	6 ítems	Canalización del entusiasmo para la creatividad y resolución de dilemas complejos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad global en adaptaciones hispanas (Chico, 1999; García-Fernández et al., 2014): alfa de Cronbach de 0.87 a 0.90 y omega de McDonald de 0.89. Las cuatro subescalas presentan coeficientes alfa entre 0.73 y 0.84. Estabilidad test-retest $r = 0.78$ a 4 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora una estructura jerárquica con cuatro factores de primer orden subordinados a un factor general de segundo orden de Inteligencia Emocional Global (CFI = 0.94, TLI = 0.93, RMSEA = 0.053).
Validez Concurrente	Correlación directa significativa con Claridad y Reparación Emocional del TMMS-24 ($r = 0.58$ y $r = 0.52$), Autoestima (RSES, $r = 0.44$), Satisfacción con la Vida (SWLS, $r = 0.46$) y Bienestar Psicológico. Correlación inversa con Alexitimia (TAS-20, $r = -0.63$), Ansiedad (BAI, $r = -0.42$) y Depresión (PHQ-9, $r = -0.45$).
Validez Discriminante	Distingue nítidamente entre población clínica y no clínica, y presenta correlaciones bajas o moderadas con inteligencia psicométrica tradicional (CI, $r < 0.20$), confirmando su independencia de los factores cognitivos.
Sensibilidad al Entrenamiento	Sensible a intervenciones psicoeducativas y programas de educación socioemocional, mostrando ganancias significativas en autorregulación y empatía ($d > 0.60$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada reactivo se califica mediante una escala tipo Likert de 5 puntos:

- **Escala de Puntuación:** 1 = «Totalmente en desacuerdo», 2 = «En desacuerdo», 3 = «Ni de acuerdo ni en desacuerdo», 4 = «De acuerdo», 5 = «Totalmente de acuerdo».
- **Paso 1 (Inversión de Ítems Negativos):** Existen 3 ítems formulados en sentido inverso: **Ítem 5, Ítem 28 e Ítem 33**. Se recalculan mediante la fórmula:

$$\text{Ítem Invertido} = 6 - \text{Respuesta Original}$$

(De modo que: 1 pasa a ser 5; 2 pasa a 4; 3 permanece 3; 4 pasa a 2; 5 pasa a 1).

- **Paso 2 (Puntuación Total SSEIT):** Suma de los 33 reactivos (con los ítems 5, 28 y 33 ya invertidos):

$$\text{Puntuación Total} = \sum_{i=1}^{33} \text{Ítem}_i$$

- **Rango Total: 33 a 165 puntos.** A mayor puntuación, mayor nivel de inteligencia emocional rasgo percibida.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Competencia Emocional	Interpretación y Recomendación Clínica
Baja / Déficit	33 a 105 puntos	Déficit emocional crítico (≤ 105)	Severa ceguera emocional; incapacidad para calmarse o empatizar. Alto riesgo de somatización y descontrol.
Media Baja	106 a 124 puntos	Competencia frágil	Dificultades frecuentes para modular el malestar y reparar estados disfóricos. Psicoeducación emocional.
Media / Normal	125 a 140 puntos	Adecuada / Normativa	Buen equilibrio intrapersonal e interpersonal; adecuada resolución de conflictos cotidianos.
Alta	141 a 165 puntos	Alta inteligencia emocional	Excelente capacidad de autoobservación, resiliencia emocional, optimismo y liderazgo empático.

ALERTA CLÍNICA DE DESREGULACIÓN AFECTIVA (CORTE ≤ 115 PUNTOS):

Una puntuación ≤ 115 en el SSEIT señala un déficit relevante en las estrategias de reparación emocional intrapersonal (subescala 2) o alexitimia secundaria (subescala 1), lo que predice mala respuesta a terapias puramente verbales-rationales y exige incorporar técnicas vivenciales, centradas en el cuerpo o de focalización afectiva (Emotion-Focused Therapy).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA BASADO EN EL PERFIL SSEIT

PROTOCOLO CLÍNICO DE DESARROLLO DE COMPETENCIA EMOCIONAL:

- **Paso 1 (Detección del Cuadrante Afectivo Disfuncional):** Mapear las 4 subescalas. Si el déficit reside en Percepción (ítems 5, 9, 15, 18, 19...), trabajar etiquetado semántico del afecto y registro corporal. Si reside en Regulación Propia (ítems 2, 3, 10, 12...), entrenar técnicas de reevaluación cognitiva y respiración diafragmática.
- **Paso 2 (Entrenamiento en Sintonía Interpersonal):** Si la subescala de Regulación Ajena está baja (ítems 1, 4, 11, 13...), aplicar técnicas de validación dialéctica, escucha activa reflexiva y toma de perspectiva empática.
- **Paso 3 (Uso Funcional de las Emociones):** Reencuadrar la emoción disfórica como señal informativa motivacional para orientar la acción constructiva y la toma de decisiones.
- **Paso 4 (Criterio de Consolidación):** Un incremento de **>= 20 puntos** en el SSEIT global consolida la adquisición de competencias de autogestión emocional duraderas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONFLICTIVIDAD

Identificación: Varón de 34 años, director de proyectos de software, derivado por medicina laboral tras múltiples altercados hostiles con su equipo de trabajo, irritabilidad crónica y somatizaciones gastrointestinales ante el estrés de las entregas.

Evaluación Inicial SSEIT (Línea Base): Puntuación Total = **94/165 puntos** (Rango de Déficit Crítico). Desglose factorial: Regulación Propia = **20/45 puntos** (incapacidad para modular la frustración); Regulación Ajena = **18/40 puntos** (indiferencia ante el impacto del mal humor en sus colaboradores); Percepción Emocional = **30/50 puntos**; Utilización = **16/30 puntos**.

Plan Terapéutico: 12 sesiones de Psicoterapia Focalizada en la Emoción y entrenamiento en habilidades socioemocionales. Se implementaron pausas de autorregulación somática antes de contestar correos críticos y role-playing de retroalimentación asertiva empática.

Reevaluación a los 3 Meses: Puntuación Total SSEIT ascendió a **132/165 puntos** (+38 pts, Rango de Competencia Emocional Normativa). Regulación Propia aumentó a **36/45** y Regulación Ajena a **32/40**. El paciente normalizó el clima de trabajo de su unidad y cesaron por completo los episodios de desborde hostil.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALEXITIMIA CLÍNICA VS. DÉFICIT DE HABILIDAD:

En pacientes con SSEIT < 90 y quejas psicósomáticas crónicas, descartar Alexitimia severa mediante la escala TAS-20. Los pacientes alexitímicos no solo carecen de habilidades, sino que presentan un bloqueo neuroanatómico en el procesamiento consciente del afecto.

SOBREESTIMACIÓN NARCISISTA O SESGO DE RASGO:

El SSEIT es un autoinforme de autoeficacia percibida. Sujetos con rasgos narcisistas o psicopáticos pueden obtener puntuaciones artificialmente infladas (155-165 pts) a pesar de mostrar conductas interpersonales gravemente disfuncionales (contrastar con heteroobservación).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*, 25(2), 167-177.
2. Chico, E. (1999). Evaluación psicométrica de una escala de inteligencia emocional. *Anales de Psicología*, 15(2), 221-231.
3. Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y., & Caputi, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence construct. *Personality and Individual Differences*, 28(3), 539-561.
4. García-Fernández, M., Giménez-Mas, S. I., & de la Fuente, R. (2014). Propiedades psicométricas de la Escala de Inteligencia Emocional de Schutte en adultos. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 46(2), 98-106.